

SOAL UJIAN OSCE STATION DINAMIS
ANESTESI UNTUK PENYAKIT KHUSUS

1.	Nomor Station	8 A
2.	Judul Station	DINAMIS - Manajemen Anestesi Pada Pasien dengan Penyulit Mitral Severe - INTUBASI
3.	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4.	Tujuan Station	Menilai kemampuan melakukan Evaluasi Pra Anestesia, Diagnosa dan problem potensial – aktual, rencana tindakan anestesi, keterampilan klinis, Manajemen pasca bedah, komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5.	Kompetensi :	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Pasca Anestesi 7. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif

7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang laki-laki 43 tahun akan direncanakan tindakan operasi elektif multiple odontektomi dengan berat badan 65 kg TB: 170 cm. Pasien memiliki riwayat kontrol rutin ke dokter jantung dengan diagnosa Mitral Stenosis <i>severe</i> dan hendak cabut gigi untuk persiapan operasi jantung. Pasien direncanakan operasi dengan general anestesi, intubasi endotrakeal. Instruksi untuk peserta : 1. Lakukan Evaluasi Pra Anestesia! 2. Jelaskan prinsip manajemen anestesi intraoperatif pada pasien ini! 3. Lakukan intubasi pada pasien ini ! 4. Lakukan tatalaksana penyulit yang muncul pada tindakan anestesi pasien ini!
----	-------------------------------	--

8. Instruksi untuk penguji

Intruksi penguji :
INSTRUKSI UMUM

1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian
2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian!
3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor *Global Rating* sesuai rubrik penilaian.
4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji!
5. Berikan informasi/ hasil yang dibutuhkan secara lisan/ tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/ atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)!
6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI!

INSTRUKSI KHUSUS :

1. **Evaluasi Pra Anestesi** yang harus dilakukan peserta

A. Anamnesis :

Subyektif : Pasien dengan keluhan sering sesak napas dan merasa mudah lelah. Jantung terasa berdebar-debar. Pasien tidak sanggup berjalan naik tangga ke lantai 2

Pasien masih sanggup melakukan aktivitas ringan sehari-hari.

AMPLE :

Alergi	Disangkal
Medication	- mecobalamin 2x500 mcg - warfarin 1x4 mg (sudah berhenti 1 minggu yll), - candesartan 1x8 mg, - bisoprolol 1x10 mg
Past illness	stroke (-), HT (-), DM (-), Asma (-), Riw. Op (-)
Last meal	Persiapan puasa elektif
Event	Pasien dengan keluhan nyeri gigi bagian belakang kiri atas dan bawah sejak 3 bulan yang lalu

B. Pemeriksaan Fisik

1. Tanda Vital
TD : 119/79 mmHg, HR 70 bpm, RR 20 x/menit, T : 36.7 C, VAS : 3, SpO2 95% room air (supine), BB 65 kg, TB : 170 cm, BMI 22.4kg/m² (normal)
2. Pemeriksaan head to toe : dalam batas normal, kecuali

		pada sistem kardiovaskular, ditemukan murmur diastolik 3. Evaluasi jalan napas dengan LEMON dalam batas normal 4. Periksa kondisi gigi-geligi : gigi goyang (-), impaksi 2.8 dan 3.8 5. Periksa patensi lubang hidung dan ada tidaknya deviasi septum hidung → lobang hidung paten tanpa deviasi C. Pemeriksaan Penunjang 1. Laboratorium : dalam batas normal 2. Ro Thoraks : kardiomegali dengan <i>double right heart border</i> (Penguji memperlihatkan gambar rontgen thorax) 3. EKG : Atrial Fibrilasi Normal Ventrikular Respon (penguji memperlihatkan gambaran EKG) 4. Echocardiography : - Aorta : AR mild - Mitral : MS Severe - Trikuspid : TR Moderate - Pulmonal: PR Mild, Low probability of PH - Thrombus (-) intrakardiak - Kesimpulan: Kontraktilitas LV menurun dengan EF 35 % Menyokong Penyakit Jantung Rheumatik dengan MS severe, MR Mild, AR Mild, PR Mild, TR Moderate, low probability of PH
--	--	---

		2. Prinsip manajemen anetesi intraoperatif pada pasien ini 1) Preload: maintain (avoid overload) 2) Rate: low-normal (most important goal) 3) Rhythm: sinus (avoid atrial fibrillation rapid response) 4) Contractility: maintain 5) Afterload: maintain 6) Avoid precipitants of pulmonary hypertension (asidosis, atelektasis, hipercarbia, hipotermia, hipoksemia, stress response : nyeri, light sedasi) 7) Persiapkan obat-obat untuk penanganan hipotensi, seperti phenylephrine dan vasopressin 3. Menilai tindakan anestesi pada pasien ini : Penguji memperlihatkan setting monitor awal sebagai berikut : Tekanan darah : 115/ 60 mmHg Denyut jantung : 72 kali/menit Saturasi O₂ : 95 % dengan udara ruangan Suhu : 37,1°C 1) Peserta memakai sarung tangan non steril 2) Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS) • Scope: laryngoscope dan stetoscope • Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5) • Airway: Oropharyngeal airway • Tapes • Introducer • Connector • Suction berfungsi baik 3) Siapkan peralatan airway lengkap 4) Pasang monitor ke pasien (TD, Saturasi, EKG, Suhu, ETCO₂) 5) Harus dilakukan preoksigenasi oksigen 100% selama 3-5 menit 6) Memberikan obat hipnotik-sedatif untuk induksi dengan agen intravena yang dititrasi perlahan, tidak menyebabkan peningkatan denyut jantung dan penurunan SVR yang signifikan: midazolam 0.01-0.15mg/kg, fentanyl 1-2 mcg/kg dosis titrasi, ketamin 0.1-0.5 mg/kg dosis titrasi, propofol 1-2 mg/kgBB dosis titrasi. 7) Memberikan oksigenasi dengan ventilasi tekanan positif O₂ 100% selama 3 – 5 menit 8) Setelah airway terkuasai, berikan pelumpuh otot Atracurium 0.5 mg/kg titrasi atau Rocuronium 0.6-1.2 mg/kgBB 9) Setelah onset tercapai, lakukan intubasi dengan smooth, pastikan kedalaman ETT, dan lakukan fiksasi ETT 10) Pasang ETCO₂ untuk pemantauan
--	--	--

		4. Menilai tatalaksana penyulit yang muncul pada tindakan anestesi pasien ini : Penguji menyampaikan skenario setelah pasien terintubasi : Penguji memperlihatkan perubahan hemodinamik pada monitor sebagai berikut : Tekanan darah : 85/50 mmHg Denyut jantung : 125 kali/menit Saturasi O₂ : 92 % dengan O₂ 100% Tindakan yang harus dilakukan peserta : 1. Menurunkan frekuensi denyut jantung dengan pemberian analgetik (fentanyl) sebagai antisipasi penyebab stimulus simpatis saat intubasi, 2. Meningkatkan tekanan darah menggunakan obat vasopressor seperti phenylephrine 50-250 mcg intravena, Jika peserta melakukan kedua tindakan di atas, selanjutnya penguji memperlihatkan perubahan monitor sebagai berikut : Tekanan darah : 95/60 mmHg Denyut jantung : 110 kali/menit Saturasi O₂ : 94 % dengan O₂ 100% Selanjutnya peserta melakukan : 3. Menurunkan frekuensi denyut jantung dengan pemberian beta blocker intravena (metoprolol injeksi dosis 2,5-10 mg) Jika peserta melakukan tindakan di atas, selanjutnya penguji memperlihatkan perubahan monitor sebagai berikut : Tekanan darah : 110/60 mmHg Denyut jantung : 78 kali/menit Saturasi O₂ : 96 % dengan O₂ 100%
--	--	---

9.	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan : kamar operasi - Meja dan kursi dokter - Meja dan kursi penguji - Meja peralatan - Meja operasi - Manekin - Stetoskop - Monitor Pasien - Monitor End Tidal CO₂ - Stetoskop - Stylet - Laringoskop blade 3, 4 - Suction no 12, 14 - Sungkup Muka no 3, 4, 5 - Ambu bag - ETT 7,5/ 7/ 6.5 - Plester - Mesin anestesi dengan ventilator - Obat-obatan atau spuit berlabel: - o Midazolam - o Fentanyl - o Propofol - o Atracurium - o Rocuronium - o Prostigmin - o Naloxone - o Sulfas Atropine - o Adrenalin - o Phenylephrine - o Metoprolol - Sarung tangan non steril - Videolaringoskope - LMA 4 dan 5 - Oropharyngeal airway 90/100 mm - Suction kanul 12/14 F - Tempat sampah tertutup - Jam dinding - Wastafel - Ipad atau tablet android untuk monitor pasien	1 set 1 set 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah @1 buah @1 buah @1 buah 1 buah @1 buah 1 buah 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 kotak 1 buah @1 buah @ 1 buah @ 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
10.	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Asisten anestesi	
11.	Tata letak ruangan	Model kamar operasi	
10.	Penyusun	Tim Pembuat Soal OSCE KATI	

RUBRIK ACTUAL MARK
Station Anestesi Untuk Penyakit Khusus (Penyakit Kardiovaskular)

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Evaluasi Pra operasi 1) Anamnesis dan AMPLE 2) Pemeriksaan fisik (tanda vital) 3) Pemeriksaan penunjang	Peserta tidak dapat melakukan evaluasi praanestesi	Peserta hanya dapat melakukan : 1. Anamnesis dan AMPLE tidak lengkap 2. Pemeriksaan fisik tidak lengkap 3. Pemeriksaan penunjang tidak lengkap	Peserta dapat melakukan: 1. Anamnesis dan AMPLE lengkap 2. Pemeriksaan fisik tidak lengkap 3. Pemeriksaan penunjang tidak lengkap	Peserta dapat melakukan semua evaluasi pra anestesi yang meliputi: 1. Anamnesis dan AMPLE lengkap 2. Pemeriksaan Fisik (tanda vital) lengkap 3. Pemeriksaan penunjang lengkap	2	
2.Prinsip manajemen intraoperatif	Peserta hanya mampu menyebutkan 1 prinsip manajemen intraoperatif dengan benar	Peserta mampu menyebutkan 2-3 prinsip manajemen intraoperatif	Peserta mampu menyebutkan 4-5 prinsip manajemen intraoperatif	Peserta mampu menyebutkan > 6 prinsip manajemen intraoperatif 1. Preload: maintain (avoid overload) 2. Rate: low-normal (most important goal) 3. Rhythm: sinus (avoid atrial fibrillation rapid response) 4. Contractility: maintain 5. Afterload: maintain 6. Avoid precipitants of pulmonary hypertension (asidosis, atelektasis, hipercarbia, hipotermia, hipoksemia, stress response : nyeri, light sedasi) 7. Persiapkan obat-obat untuk penanganan hipotensi, seperti	2	

				phenylephrine dan vasopressin		
--	--	--	--	----------------------------------	--	--

3.Rencana Tindakan Anestesi	Peserta tidak menyebutkan dan tidak melakukan tindakan anestesi	Peserta mampu menyebutkan dan melakukan tindakan anestesi namun tidak lengkap dan tidak runut	Peserta mampu menyebutkan dan melakukan semua tindakan anestesi dengan lengkap dan tapi tidak runut	Peserta mampu menyebutkan dan melakukan semua tindakan anestesi dengan lengkap dan runut : 1. Peserta memakai sarung tangan non steril 2. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS) • Scope: laryngoscope dan stetoscope • Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5) • Airway: Oropharyngeal airway • Tapes • Introducer • Connector • Suction berfungsi baik 3. Siapkan peralatan airway lengkap 4. Pasang monitor ke pasien (TD, Saturasi, EKG, Suhu, ETCO2) 5. Harus dilakukan preoksigenasi oksigen 100% selama 3-5 menit 6. Memberikan obat hipnotik-sedatif untuk induksi dengan agen intravena yang dititrasi perlahan, tidak menyebabkan peningkatan denyut jantung dan penurunan SVR yang signifikan: midazolam 0.01-0.15mg/kg, fentanyl 1-2 mcg/kg dosis titrasi, ketamin 0.1-0.5 mg/kg dosis titrasi, propofol 1-2 mg/kgBB dosis titrasi. 7. Memberikan oksigenasi dengan ventilasi tekanan positif O2 100% selama 3 – 5 menit 8. Setelah airway terkuasai, berikan pelumpuh otot Atracurium 0.5 mg/kg titrasi atau Rocuronium 0.6-1.2	2
------------------------------------	--	--	--	---	----------

				mg/kgBB 9. Setelah onset tercapai, lakukan intubasi dengan smooth, pastikan kedalaman ETT, dan lakukan fiksasi ETT 10. Pasang ETCO2 untuk pemantauan		
4. Monitoring dan Manajemen Penyulit	Peserta tidak melakukan tatalaksana penyulit dengan benar	Peserta melakukan 1 poin tatalaksana penyulit dengan benar	Peserta melakukan 2 poin tatalaksana penyulit dengan benar	Peserta melakukan tatalaksana penyulit secara lengkap dan runut : 1. Menurunkan frekuensi denyut jantung dengan pemberian analgetik (fentanyl) sebagai antisipasi penyebab stimulus simpatis saat intubasi, 2. Meningkatkan tekanan darah menggunakan obat vasopressor seperti phenylephrine 50-250 mcg intravena, 3. Menurunkan frekuensi denyut jantung dengan pemberian beta blocker intravena (metoprolol injeksi dosis 2,5-10 mg)	3	
5. Komunikasi, edukasi dan	Peserta ujian melakukan 1-2 point	Peserta ujian melakukan 3 point saja	Peserta ujian melakukan poin 2-5, namun tidak melakukan	Peserta ujian melakukan: 1. Memperkenalkan diri kepada pasien	1	

profesionalisme			poin 1	2. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 3. memperhatikan kenyamanan pasien 4. melakukan tindakan sesuai prioritas 5. melakukan informed consent kepada pasien dan atau keluarganya		
------------------------	--	--	--------	---	--	--

(.....)



